

# Note sur la dimension Santé

## Pourquoi l'assurance maladie ne peut pas la porter seule

Pipeline PythonIPM — IPM Côte d'Ivoire, EHCVM 2021

Août 2026

### Résumé

La dimension Santé de l'IPM ivoirien a d'abord reposé sur un unique indicateur — l'absence de couverture maladie — faute de pouvoir mesurer la mortalité juvénile dans l'EHCVM. Cette note montre pourquoi ce montage produisait un indice non plausible, expose le mécanisme arithmétique en cause, documente les décisions prises — l'ajout de l'insécurité alimentaire mesurée par l'échelle FIES de la FAO, puis celui du renoncement aux soins pour raison de coût — et en mesure l'effet. Elle se termine sur ce qui reste ouvert.

## 1 Le point de départ

Le tableau de référence national place dans la dimension Santé un indicateur de **mortalité juvénile**. L'EHCVM 2021 ne permet pas de le construire : l'enquête n'a ni module décès ni historique des naissances. La base des chocs enregistre bien un « décès d'un membre du ménage » — 1 328 ménages sur trois ans, avec la date — mais **sans l'âge du défunt**. Il est donc impossible d'isoler les décès d'enfants de moins de dix-huit ans.

La dimension a d'abord été mesurée par un seul indicateur de substitution : *aucun membre du ménage n'est couvert par une assurance maladie*. Le choix se défendait — la question est renseignée pour 100 % des ménages, sans biais de sélection, et se lit sans ambiguïté.

## 2 Le problème

Avec quatre dimensions équipondérées à 0,25, un indicateur seul dans sa dimension **porte tout son poids**. Or 93,4 % des ménages ivoiriens n'ont aucun membre assuré. Trois conséquences en découlent, toutes arithmétiques et non statistiques.

### 2.1 L'indicateur dominait le score

L'assurance maladie apportait en moyenne **0,2336** sur un score moyen de 0,4603, soit **50,8 % du score de privation** à elle seule. Les douze autres indicateurs se partageaient l'autre moitié.

### 2.2 Elle fonctionnait comme un laissez-passer vers le seuil

Un ménage non assuré partait déjà à 0,25 sur les 0,3333 requis pour être déclaré pauvre. Deux privations de conditions de vie ( $2 \times 0,0417 = 0,0833$ ) suffisaient alors à franchir exactement le seuil. **403 ménages** se trouvaient dans ce cas précis, et 396 avaient un score exactement égal à  $k$  : un ménage sur trente basculait sur une différence de troisième décimale.

### 2.3 Le résultat n'était pas plausible

Une simulation retirant l'indicateur et renormalisant les poids donne :

| Configuration                                | H (population pauvre) |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Treize indicateurs, assurance seule en Santé | 79,7 %                |
| Les mêmes, sans l'assurance maladie          | 45,7 %                |

Le second ordre de grandeur est celui publié pour la Côte d'Ivoire dans la table globale de l'OPHI. Le premier ne l'est pas.

### Le fond du problème

Un indicateur qui prive 93 % de la population ne discrimine plus : il déplace le niveau de l'indice sans rien apprendre sur *qui* est pauvre. Ce n'était pas une erreur de calcul — le code appliquait fidèlement les choix actés — mais la rencontre de deux décisions qui se combinent mal : substituer l'assurance maladie à la mortalité juvénile, *et* conserver quatre dimensions équipondérées.

## 3 La décision

Un **second indicateur** a été ajouté à la dimension Santé : l'insécurité alimentaire mesurée par l'échelle **FIES** (*Food Insecurity Experience Scale*) de la FAO, présente dans la section 8A de l'EHCVM. Huit questions oui/non portant sur les douze derniers mois, ordonnées par sévérité croissante, dont le nombre de « oui » forme un score de 0 à 8.

| # | Question                                  | Sévérité |
|---|-------------------------------------------|----------|
| 1 | inquiétude de manquer de nourriture       | légère   |
| 2 | n'a pas pu manger sain et nutritif        | légère   |
| 3 | a mangé peu varié                         | légère   |
| 4 | a sauté un repas                          | modérée  |
| 5 | a mangé moins que nécessaire              | modérée  |
| 6 | plus de nourriture dans le ménage         | modérée  |
| 7 | a eu faim sans manger                     | sévère   |
| 8 | est resté une journée entière sans manger | sévère   |

Le seuil retenu est **score**  $\geq 4$ , qui correspond à l'insécurité alimentaire modérée ou sévère — le seuil standardisé de l'**indicateur ODD 2.1.2**. Il n'a donc pas fallu inventer un seuil : celui-ci est comparable aux publications de la FAO.

### 3.1 Pourquoi cet indicateur plutôt qu'un autre

La justification est de fond, et pas seulement d'opportunité. Dans l'IPM mondial, la dimension Santé est composée de la **nutrition** et de la mortalité juvénile. Remplacer la seconde — impossible à mesurer ici — par une mesure de la première ne dénature pas la dimension : c'est son autre pilier officiel.

S'y ajoute une raison statistique. La distribution du score FIES le sépare nettement de l'assurance maladie :

| Score FIES       | 0    | 1   | 2   | 3    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Part des ménages | 30,5 | 7,5 | 7,8 | 10,1 | 9,2 | 9,8 | 7,9 | 8,5 | 7,4 |

Un tiers des ménages à zéro, le reste étalé sur toute l'échelle. L'assurance maladie, elle, oppose 93,4 % à 6,6 % : elle sépare mal parce qu'elle ne varie presque pas. C'est exactement ce qu'on demande à un indicateur de privation — séparer — et c'est ce que le FIES fait.

Le taux de privation retenu s'établit à **42,7 % des ménages**, soit 40,8 % de la population.

## 4 Le troisième indicateur : le renoncement aux soins

Un **troisième indicateur** a ensuite été ajouté à la dimension : un ménage est privé si l'un de ses membres a eu un problème de santé dans les 30 derniers jours (question 3.01), n'a *pas* consulté (3.05) et a cité le **coût** comme raison principale (3.06, modalités « trop cher » et « manque d'argent »).

Là où l'assurance maladie mesure une *couverture* formelle — largement absente en Côte d'Ivoire, donc peu discriminante — le renoncement aux soins mesure un **accès effectif empêché par l'argent**. C'est un fait, pas un droit théorique : le ménage a été malade, et n'a pas pu se soigner. L'indicateur prive **9,2 % des ménages** (8,9 % de la population). Il ne peut être privé que parmi les 67,2 % de ménages ayant connu un problème de santé sur la période : un ménage où personne n'a été malade n'est pas privé.

## 5 L'effet mesuré

La dimension Santé compte désormais trois indicateurs à **0,0833** chacun : le poids de l'assurance maladie est le tiers de ce qu'il était.

|                                         | Avant<br>(assurance seule) | Étape 2<br>(+ FIES) | Aujourd'hui<br>(+ renoncement) |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Indicateurs de l'IPM                    | 13                         | 13                  | 16                             |
| Poids de l'assurance maladie            | 0,2500                     | 0,1250              | 0,0833                         |
| Part de l'assurance dans le score moyen | 50,8 %                     | 29,4 %              | 19,9 %                         |
| Score moyen $c_i$                       | 0,4603                     | 0,3968              | 0,3918                         |
| <b><math>H</math> — incidence</b>       | <b>79,7 %</b>              | <b>65,8 %</b>       | <b>58,0 %</b>                  |
| Vulnérables                             | 12,7 %                     | 19,1 %              | 22,8 %                         |
| Pauvreté sévère                         | 44,0 %                     | 26,8 %              | 26,1 %                         |
| Ménages au score exactement égal à $k$  | 396                        | 928                 | 16                             |

La colonne « Aujourd'hui » n'isole pas le seul effet du renoncement aux soins : elle intègre les trois indicateurs ajoutés en même temps (renoncement, emploi agricole de subsistance, promiscuité), qui font passer l'IPM de treize à seize indicateurs.

L'effet est net sur la pauvreté sévère, qui passe de 44,0 % à 26,1 % : c'est là que la domination d'un indicateur unique se voyait le plus. La dimension Santé, qui pesait 40,5 % de l' $M_0$  pour un poids nominal de 25 %, en pèse désormais **27,9 %** — l'assurance maladie 16,7 %, l'insécurité alimentaire 9,0 %, le renoncement aux soins 2,2 %.

## 6 Limites assumées

**Le FIES n'est pas une mesure d'état nutritionnel.**

Il mesure l'insécurité alimentaire *vécue*. L'OPHI, lui, mesure la nutrition par l'anthropométrie — indice de masse corporelle des adultes, retard de croissance des enfants. L'EHCVM n'a pas de module anthropométrique : le FIES est le meilleur substitut disponible, pas un équivalent.

**C'est du déclaratif rétrospectif sur douze mois.**

Il est donc sensible à la saison de collecte. Les deux vagues de l'EHCVM ayant été collectées à des saisons différentes, une vérification de la comparabilité entre vagues reste à mener.

**195 ménages (1,5 %) n'ont pas de score complet**

, pour cause de non-réponse ou de refus sur au moins un des huit items. Ils sont traités comme non privés, conformément à la convention générale du pipeline. C'est un choix — celui de ne pas pénaliser un refus de répondre — et non une déduction.

## 7 Ce qui reste ouvert

L'assurance maladie pèse encore **16,7 % de l'IPM** — la deuxième contribution de tout le système — pour un indicateur qui prive 93 % des ménages. Trois leviers restent disponibles, non tranchés à ce jour.

1. **Abandonner l'assurance maladie** et garder le FIES et le renoncement aux soins en Santé. Cohérent avec le constat qu'un indicateur à 93 % n'informe pas ; la dimension garderait cette fois deux jambes, ce qui n'était pas le cas au moment du premier arbitrage.
2. **Rééquilibrer les dimensions.** Rien n'oblige à quatre dimensions égales. L'IPM mondial en retient trois — Santé, Éducation, Niveau de vie — à un tiers chacune.
3. **Revoir d'autres seuils dans le même esprit.** L'année de scolarité (72,5 %), l'énergie de cuisson (76,8 %) et les toilettes (77,3 %) privent aussi une large majorité des ménages, et posent la même question de pouvoir discriminant. Le cas s'est reproduit hors Santé : l'emploi agricole de subsistance prive 48,1 % des ménages et apporte à lui seul 16,9 % de l'M<sub>0</sub>, contre 1,6 % au chômage, à poids identique.

Ces arbitrages relèvent du cadrage et non de la technique : chacun se modifie en une ligne dans `pipeline/02_construction_matrice_situationnelle.py`.